Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Maux de tête inhabituels

Mal de tête nouveau, différent de d'habitude ou qui s'aggrave. Tout public ; non communicant : changement de comportement.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · mal de tête **brutal, « coup de tonnerre »** (maximal en moins d'une minute) ; avec fièvre et taches violacées, raideur de nuque, paralysie, trouble de la parole, somnolence ou convulsion.

1 · Je sécurise

- Installer au calme, dans une pièce peu éclairée ; ne pas laisser seule.
- Vomit ou somnolente : sur le côté ; PLS si elle ne répond pas normalement.
- Plusieurs personnes ont mal à la tête en même temps : penser au **monoxyde de carbone** → aérer, évacuer, 15.

2 · J'observe et je mesure

- Début **brutal** ou progressif ? Heure ? Différent des maux de tête habituels (migraine connue) ?
- **TA**, pouls, **température**, SpO2 ; **glycémie capillaire (AS/AP)** ; douleur EN ou Algoplus.
- Chute ou choc à la tête récent ? **Anticoagulant ou antiagrégant ?** Traitement nouveau ?
- Vomissements, fièvre, nuque raide, gêne à la lumière, trouble de la vue, de la parole, de l'équilibre ?

3 · J'agis

- Sans signe de gravité : IDE pour évaluation ; noter heure et intensité.
- Paracétamol **uniquement** selon le protocole « Paracétamol – Douleur et/ou fièvre », validé par l'IDE.
- Protocole individuel (migraine, HTA) : prévenir l'IDE, qui l'applique ou le valide.
- Signe d'AVC → protocole « Suspicion d'AVC » ; après choc → protocole « Traumatisme crânien ».

Je ne fais pas

- Donner un antalgique ou un anti-inflammatoire sans validation de l'IDE.
- Faire manger ou boire une personne somnolente ou qui vomit.
- Laisser seule une personne qui a chuté et se plaint de la tête.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Mal de tête **brutal, en coup de tonnerre**.
- Avec fièvre et taches violacées (purpura), raideur de nuque, somnolence, confusion ou convulsion.
- Avec paralysie, trouble de la parole ou de la vue ; après un choc sous **anticoagulant**.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Toujours** un mal de tête inhabituel, même sans signe de gravité.
- PAS > 200 mmHg (aux 2 bras), fièvre, vomissements, EN > 5 ou Algoplus > 3 : IDE sans délai ; injoignable → 15.

Je surveille et je trace

- Douleur (même échelle), conscience, comportement, vomissements, TA, température.
- Douleur qui persiste ou revient malgré le traitement : avis médical (IDE → médecin ou DOTR).
- Tracer : heure de début, constantes, gestes, avis donnés.

Mention de sécurité

Mal de tête brutal, avec fièvre, signe neurologique ou après un choc sous anticoagulant = 15. Pas d'antalgique sans validation IDE.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SFEMC/SFN, Moisset X et al., Recommandations pour la prise en charge d'une céphalée en urgence, Douleurs 2018;19:4-16 ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD n° 13 (2016) ; ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap fiche 13 (2023) ; ASSURE IDF, fiche 2 (2023) ; SFMU, RPP Traumatisme crânien léger (2022).

Réf. DOTR-AS-CEPHAL | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature